

Judul:

“Belum optimalnya Capaian Kinerja Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) di Puskesmas Tenam Kabupaten Batang Hari Tahun 2025”

BAB I – PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan. Salah satu program prioritas nasional adalah pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi dan diabetes mellitus. Sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas, mahasiswa memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program PTM.

2. Profil Singkat Puskesmas

Puskesmas Panerokan merupakan fasilitas kesehatan di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, dengan wilayah kerja mencakup 12 desa. Program unggulan adalah Posbindu PTM dan kunjungan prolanis.

3. Alasan Pemilihan Klaster Layanan

Klaster PTM dipilih karena tingginya prevalensi hipertensi dan DM serta capaian indikator program yang masih rendah.

4. Rumusan Masalah Evaluasi Kinerja

Bagaimana pelaksanaan layanan PTM di Puskesmas Panerokan?

5. Tujuan Evaluasi

Melakukan evaluasi kinerja layanan PTM serta menyusun rencana perbaikan layanan

6. Manfaat Laporan

Memberikan rekomendasi perbaikan program PTM dan meningkatkan kemampuan profesional petugas kluster.

Bab 1 disusun maksimal 2 halaman atau 100 kata.

BAB II – GAMBARAN UMUM PROGRAM

1. Deskripsi Klaster Layanan (SOP, alur, tugas pokok)

Program PTM bertujuan melakukan deteksi dini faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, gula darah, obesitas, merokok, dan aktivitas fisik rendah.

2. Capaian Kinerja Program (3–5 indikator)

No	Program	Target	Capaian	
			2024	2025
1	Skrining PTM	80%	40%	49%
2	Rasio pasien hipertensi terkontrol	50%	28%	34%

3. Peran Mahasiswa dalam Setiap Kegiatan
 - a. Melakukan skrining PTM di Posbindu
 - b. Edukasi hipertensi, DM, dan gaya hidup sehat
 - c. Entering data SIPTM
 - d. Monitoring obat pasien prolans

4. Bukti Kinerja (dokumentasi dilampirkan di lampiran)

Dilampirkan berupa foto kegiatan, form skrining, dan laporan bulanan PTM.

BAB III – EVALUASI KINERJA

1. Analisis Kinerja

Input	Proses	Output	Outcome
SDM terbatas, alat GDA sering tidak kalibrasi	Skrining kurang merata, edukasi belum standar	Capaian skrining rendah	Kendali hipertensi masih rendah

5. Analisis Masalah (Root Cause Analysis)

Masalah utama: Skrining PTM rendah

- Why 1: Kegiatan Posbindu jarang dilakukan
- Why 2: Kader kurang aktif
- Why 3: Pelatihan kader tidak rutin
- Why 4: Anggaran terbatas
- Why 5: Pengelolaan program belum optimal

6. Rekomendasi Perbaikan (Quality Improvement)

Membuat minimal 1 rencana perbaikan (PDSA).

Plan : Mengaktifkan kembali kader melalui pelatihan mini

Do. : Pelatihan kader 1 kali dan pendampingan lapangan

Study : Skrining meningkat 14% dalam 2 bulan

Act. : Menetapkan jadwal Posbindu rutin tiap desa

Bab 2 disusun maksimal 5 halaman

BAB IV – KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan Evaluasi
Pelaksanaan program PTM di Puskesmas Panerokan belum optimal terutama pada aspek cakupan skrining dan kendali hipertensi.
2. Saran untuk Puskesmas
Penguatan kader Posbindu dan Alokasi anggaran alat dan pelatihan PTM
3. Saran untuk Pengembangan Profesional Mahasiswa
Meningkatkan kemampuan manajemen program serta memperdalam kompetensi edukasi dan konseling PTM

Bab 4 disusun maksimal 2 halaman atau 500 kata